

仲恩生醫 7729 投資研究報告

日期:2026/07/08

更新理由:日本 PMDA 正式送件+台灣 FDA 納入 T-RMAT 輔導+CDMO 廠簽約量產

台日 SCA 藥證主軸已成形，美國 SCA 二期選擇權，杭丁頓舞蹈症 HD 長線夢想

一、投資結論

仲恩生醫目前最核心的投資價值，不需要靠 Huntington's disease，HD，光是

台日 SCA 藥證 + 台日商轉 + 美國 SCA 二期啟動就是一項極度驚人的價值未發現標的。

目前給仲恩的主要結論如下：

項目	判斷
日本暫時性藥證通過機率	82%~88%
若確認 PMDA 正式受理並進入優先審查	85%~90%
若日本先過，台灣跟進機率	88%~94%
日本過證後基準目標價	320~480 元
日本過證 + 美國 SCA 二期啟動	340~525 元
若市場相信台日 8,000 人治療模型	480~745 元
HD 題材	長線夢想選擇權，若有進度則目標價上修

二、公司與產品簡介

仲恩生醫的核心產品是 **Stemchymal®**，主要針對 **脊髓小腦性共濟失調**，**Spinocerebellar Ataxia**，**SCA**。這是一種逐漸惡化的神經退化疾病，病人會出現走路不穩、協調能力變差、語言障礙、吞嚥困難，最終可能需要輪椅或長期照護。

目前 **SCA** 缺乏真正可以延緩疾病進展的上市治療。這也是仲恩的核心價值所在：如果 **Stemchymal** 能在日本、台灣取得臨時性或有附款藥證，就可能成為少數能夠改變疾病進程的神經罕病治療。

Stemchymal 的治療設計是細胞治療，不是傳統小分子藥。它的商業價值取決於四件事：

1. 是否取得日本暫時性藥證。
 2. 台灣是否跟進有附款許可。
 3. 是否能穩定量產並通過 **GMP / GCTP** 查核。
 4. 實際可治療病人數視為關鍵。
-

三、日本藥證：為什麼取證機率高？

日本合作方 **REPROCELL** 已公告，向日本提交 **Stemchymal** 的製造銷售承認申請，適應症是抑制 **SCA3 / SCA6** 患者共濟失調進展。**REPROCELL** 也說明，**Stemchymal** 已取得日本 **MHLW** 孤兒再生醫療產品指定，符合 **PMDA** 優先審查資格，目標審查期間為申請受理後 9 個月。

這件事有三個重要意義。

第一，日本端不是停留在口頭規劃，而是已經正式送件。對生技股來說，正式送件是一個非常重要的去風險節點。

第二，日本再生醫療產品有「條件及期限付承認」制度。這種制度本來就是針對細胞治療、再生醫療產品，在安全性確認、療效具有合理可能性、且能進行上市後追蹤的情境下，讓產品提前上市，再透過上市後資料補足正式藥證證據。日本 **PMD Act** 對再生醫療產品設有 **conditional and time-limited approval** 機制，探索性臨床試驗若呈現 **probable benefit** 且安全性可確認，便可能進入

此路徑。

第三，日本 PMDA 的送件前諮詢文化通常較嚴謹。若資料包完全不具可審查性，日方授權夥伴通常不會貿然送件。因此，正式送件本身就是強正向訊號。過往歷史從未有 PMDA 接受送件後被退回案例發生。

我目前給日本通過機率：

條件	機率
目前已送件	82%~88%
若確認 PMDA 正式受理	85%~90%
若 GMP / GCTP 查核順利	88%~92%

需要注意的是：送件不等於核准。真正還要觀察的是 PMDA 是否正式受理、是否有重大補件、GMP / GCTP 查核是否順利，以及最終標籤是否被過度限縮。

四、台灣藥證跟隨日本腳步

第一，台灣再生醫療制度剛上路，政策面需要成功案例。若第一批符合條件的再生醫療藥品完全沒有實績，制度推動效果會大打折扣。

第二，仲恩已列入 T-RMAT 輔導專案，這代表主管機關願意讓這個案子進入加速輔導與審查準備流程。這不是正式核准，但已經比一般藥品申請更進一步。

第三，如果日本先核准，台灣不需要從零開始承擔全部法規判斷風險。日本 PMDA 對再生醫療產品的審查經驗、GMP / GCTP 要求與上市後調查設計，都可以成為台灣審查時的重要參考。

因此，台灣過證機率如下：

狀態	機率
目前已列入 T-RMAT 輔導	80%~88%
若日本先核准	88%~94%

台灣不是獨立賭局，而是高度依賴日本審查結果。

如果日本過，台灣過證機率應明顯提高；如果日本重大補件或延後，台灣也會跟著保守。

五、治療人數模型

仲恩估值現階段最重要的已經不是「有沒有藥證」而已，而是市場最後相信多少病人會接受治療。

保守模型通常會先抓中重度、符合特定 **SARA** 分數的病人並且在給予保守折扣。但我認為實際商轉後，**SCA** 的治療人數只會上修。

原因為 SCA 這是一個會逐漸失去行走、協調、語言和生活能力的疾病。

對病人與家屬而言，如果治療有機會延緩惡化，輕症患者很可能更希望早點治療，避免進入不可逆的重症階段。因此，我認為未來可能形成：

- 中重度病人：健保或罕病給付。
- 輕中度病人：部分自費或商業保險。
- 高風險家族病人：更早期介入的需求。

日本官方難病資訊中心指出，日本脊髓小腦變性症若包含部分相關疾病，患者數超過 3 萬人，其中約 1/3 是遺傳性脊髓小腦變性症，常見遺傳型包括 **SCA3**、**SCA6**、**SCA31**、**DRPLA** 等。

台日總目標人數超過 3 萬人，我們給予極度保守滲透率以及疾病可持續治療之折扣。

我建議用三層模型看：

模型	日本治療人數	台灣治療人數	合計
保守模型	2,500	500	3,000 人
基準模型	4,500	1,000	5,500 人
積極模型	6,500	1,500	8,000 人
上緣模型	8,000	2,000	10,000 人

這份報告的基準估值，採用 **5,500 人模型**。

六、每位病人的營收與 EPS 公式

我們用最簡單的方式計算。

- 每位病人每年治療 3 劑。
- 每劑終端藥價保守約 100 萬台幣。
- 每位病人每年終端藥費約 300 萬台幣。
- 日本由 REPROCELL 負責銷售，仲恩主要取得出貨收入與分潤，因此日本每位病人每年仲恩可認列約 150 萬台幣。
- 台灣若由仲恩主導銷售，台灣每位病人每年仲恩可認列約 300 萬台幣。
- 現增後股本約 8,034 萬股。
- 成熟期稅後淨利率採 40%。

核心公式：

仲恩營收 = 日本治療人數 × 150 萬 + 台灣治療人數 × 300 萬

$EPS = \text{仲恩營收} \times \text{稅後淨利率} \div \text{股數}$

每 1,000 位病人的 EPS 貢獻如下：

病人來源 每 1,000 人仲恩營收 40% 淨利率 EPS

日本 15 億 約 7.5 元

台灣 30 億 約 14.9 元

台日混合 約 17.5~18 億 約 8~10 元

結論：

台日每增加 1,000 位穩定治療病人，仲恩 EPS 約增加 8~10 元。

七、台日 SCA 成熟期 EPS 模型

情境 日本人數 台灣人數 合計人數 仲恩營收 EPS，40%淨利率

保守模型	2,500	500	3,000	52.5 億	26.1 元
稍高模型	3,000	700	3,700	66.0 億	32.9 元
基準模型	4,500	1,000	5,500	97.5 億	48.5 元
積極模型	6,500	1,500	8,000	142.5 億	70.9 元
上緣模型	8,000	2,000	10,000	180.0 億	89.6 元

這張表是整份報告最重要的核心。

病人數 3,000 人，仲恩是 EPS 26 元的公司。

病人數 5,500 人，仲恩是 EPS 48 元的公司。

病人數 8,000 人，仲恩是 EPS 70 元以上的公司。

但對比總病患數超過 30000 人的龐大規模來說，此假設都相對保守

八、合理股價公式

合理股價不能直接用成熟期 EPS 乘本益比，因為成熟銷售通常要幾年後才達成。因此我用折現模型：

合理股價

$$= 2030E \text{ EPS} \times \text{目標 PE} \div (1 + \text{折現率})^3 \times \text{商轉實現係數}$$

模型參數：

參數	假設
目標 PE	18～20 倍
折現率	15%
折現年數	3 年
商轉實現係數	55%～75%

商轉實現係數代表：即使日本藥證通過，藥價、給付、標籤、醫院導入、病人

篩選、產能放大仍需要時間驗證，因此不能直接用 100% 成熟價值評價。

九、台日 SCA 目標價

1. 保守 3,000 人模型

2030E EPS = 26.1 元。

低估值 = $26.1 \times 18 \div 1.15^3 \times 55\%$ = 約 170 元

高估值 = $26.1 \times 20 \div 1.15^3 \times 75\%$ = 約 258 元

所以：

若市場只相信 3,000 人模型，日本藥證通過後合理價約 170~260 元。

2. 基準 5,500 人模型

2030E EPS = 48.5 元。

低估值 = $48.5 \times 18 \div 1.15^3 \times 55\%$ = 約 316 元

高估值 = $48.5 \times 20 \div 1.15^3 \times 75\%$ = 約 479 元

所以：

若市場相信台日 5,500 人模型，日本藥證通過後合理價約 320~480 元。

這是我目前認為最合理的基準目標價。

3. 積極 8,000 人模型

2030E EPS = 70.9 元。

低估值 = $70.9 \times 18 \div 1.15^3 \times 55\%$ = 約 462 元

高估值 = $70.9 \times 20 \div 1.15^3 \times 75\%$ = 約 700 元

所以：

若市場相信台日 8,000 人模型，日本藥證通過後合理價約 460~700 元。

4. 上緣 10,000 人模型

2030E EPS = 89.6 元。

低估值 = $89.6 \times 18 \div 1.15^3 \times 55\%$ = 約 583 元

高估值 = $89.6 \times 20 \div 1.15^3 \times 75\%$ = 約 884 元

所以：

若市場相信台日 10,000 人模型，上緣合理價約 580~880 元。

十、美國 SCA 二期啟動的價值

美國 SCA 二期啟動本身不會立刻帶來營收，但它會讓仲恩從「台日商轉公司」變成「全球 SCA 資產」。

National Ataxia Foundation 估計，美國約有 15,000~20,000 名 SCA 患者，另外還有更多 recessive、sporadic 或未知型 ataxia 患者。

我們不直接把美國所有 SCA 都算進去，而是保守估：

- 美國可治療 SCA3 / SCA6 保守估計約 4,000 人。
- 年藥價 20 萬美元。
- 美國峰值銷售額約 8 億美元。
- 仲恩未來若授權，保守抓 18% 經濟權益分潤。
- 二期啟動階段成功率抓 20%~30%。

用 rNPV 粗估，美國 SCA Phase II 啟動的選擇權價值約：

20~45 元 / 股

所以：

台日病人數模型 台日 SCA 本體價值 加美國 SCA 二期啟動 合理股價

3,000 人	170~260	+20~45	190~305 元
---------	---------	--------	-----------

台日病人數模型 台日 SCA 本體價值 加美國 SCA 二期啟動 合理股價

5,500 人 320~480 +20~45 **340~525 元**

8,000 人 460~700 +20~45 **480~745 元**

因此，所謂「日本藥證通過 + 美國 SCA 二期啟動」的 300~500 元，並不是憑空想像，而是：

台日 5,500 人模型：320~480 元

+ 美國 SCA 二期選擇權：20~45 元

= 340~525 元

十一、第一年獲利？

這是短期股價能否提前反應的關鍵。

仲恩近年已陸續布局自動化細胞擴增與 CDMO 合作，代表公司不是只準備小量供應，而是在準備商業化放量。

Terumo BCT 官方指出，與 Steminent 的合作目標，是導入 Quantum Flex 自動化細胞擴增系統，以改善 MSC 製造的一致性、可放大性與效率。

第一年出貨量與 EPS 關係如下：

第一年度出貨量	約當治療人數	仲恩可認列營收	40% 淨利率產品 EPS	扣既有費用後公司 EPS
900 劑	300 人	5.25 億	2.6 元	接近損平
2,000 劑	667 人	11.7 億	5.8 元	EPS 約 3~4 元
3,000 劑	1,000 人	17.5 億	8.7 元	EPS 約 6~7 元

結論：

若第一年接近 900~1,000 劑(300 人)，仲恩就可能接近損益兩平或小賺。由虧轉盈情境下市場會提前反映 2029~2030 獲利。

所以只要跨過 300 人(1000 劑)的治療門檻，仲恩股價就會急速反映

而我認為跨越門檻是相當容易的，因為光是台日二期就有超過 100 位受試者，而細胞製劑罕病治療，第一年接受治療人數通常為試驗受試者的 3~8 倍。所以跨越 300 人是基本門檻。

十二、收購對標：Reata / Skyclarys 給了估值天花板

2023 年，Biogen 宣布以約 73 億美元企業價值收購 Reata，核心資產是 Friedreich's ataxia 藥物 Skyclarys。

這個案例給仲恩一個重要啟示：

神經退化罕病即使病人數不大，只要是首款或少數有效治療，仍可能獲得極高估值。

不過 Reata 當時已有 FDA 核准藥物，而仲恩目前仍處在日本送件、台灣 T-RMAT、美國 SCA 二期僅在收案階段。

所以我會這樣看：

階段	合理估值方式
日本藥證通過	台日 SCA EPS 折現
日本 + 台灣取證	台日 5,500~8,000 人模型
美國 SCA 二期啟動 加選擇權	20~45 元
美國 SCA 二期正向 開始用全球授權 / 收購邏輯重估	

Reata 案例是仲恩未來若走向全球神經罕病平台時的夢想級別天花板。

十三、HD 夢想

Huntington's disease，HD，和 SCA 一樣屬於神經退化疾病，而且在歐美病人數更大。Huntington's Disease Society of America 估計，美國約有 41,000 名有症狀 HD 患者，另有超過 200,000 人具有遺傳風險。

但 HD 在這份報告中只列為：

長期夢想選擇權，不納入基準目標價。

如果未來 HD 有動物模型強訊號、IND 或早期臨床 PoC，仲恩才有機會從「SCA 藥證股」重估為「PolyQ 神經退化平台公司」。

此時股價會向千元以上靠攏

十四、投資催化時間表

時間	事件	影響
2026 H2	PMDA 是否正式受理、是否補件	決定日本藥證機率是否再上修
2026 H2	GMP / GCTP 查核	決定細胞藥商轉可信度
2026 Q4~ 2027 Q1	台灣 T-RMAT 輔導與有附款許可進度	決定台灣是否跟隨日本
2027 Q1	日本暫時性藥證結果	最大股價催化
2027~2028	首批商業化出貨	決定是否從故事變成營收
2027~2028	美國 SCA 二期啟動	提升全球選擇權

十五、主要風險

1. 日本藥證風險

送件不等於核准。若 PMDA 要求重大補件，或 GMP / GCTP 查核不順，股價會重新折價。

2. 台灣跟隨不如預期

雖然我認為台灣會高度跟隨日本，但若台灣審查機關採取極保守態度，時程可能延後。

3. 標籤過度限縮

若藥證只限非常狹窄的中重度族群，輕症自費與更大病人數模型會被打折。

4. 藥價不如預期

模型假設每年治療費約 300 萬台幣。若日本或台灣實際藥價低於預期，EPS 會下降。

5. 產能放大不如預期

細胞藥不是一般小分子藥。製程、品質、批次一致性、冷鏈和保存都可能限制放量速度。

6. 資金稀釋風險

若美國 SCA、HD 或其他適應症快速推進，公司仍可能需要再募資，股本稀釋會影響 EPS。

十六、最終目標價結論

我建議把仲恩分成三個目標價層級。

保守目標價：170～260 元

條件：

- 日本藥證通過。
- 市場只相信 3,000 人治療模型。
- 台灣雖然跟進，但速度較慢。
- 第一年度出貨量不高。

基準目標價：320～480 元

條件：

- 日本藥證通過。
- 台灣跟隨日本，通過機率明顯提高。
- 市場相信台日 5,500 人治療模型。
- 輕中度自費、中重度給付的市場想像開始形成。

這是我目前最認同的目標價區間。

積極目標價：480～745 元

條件：

- 日本藥證通過。
 - 台灣跟進。
 - 美國 SCA 二期啟動。
 - 市場相信台日 8,000 人模型。
 - 商轉第一年出貨量接近或超過 1,000 劑。
-

十八、最終結論

仲恩目前最核心的價值，是台日 SCA 藥證與商轉。光是台日 5,500 人模型，合理價在日本藥證通過後(2027Q1)就可以上修到 320～480 元；若加上美國 SCA 二期啟動，合理價可進一步到 340～525 元。

而本篇報告在於發掘仲恩此時此刻所處的價值窪地。

綜上所述，本篇報告用極為保守的滲透率，加上相對保守的細胞治療藥價以及光是台日兩地的取證+美國 SCA 二期啟動來評估仲恩的價值。其地板價就已是現在股價的 5 倍左右。而此兩件事基本上可以確立是一定會成功的，加上近期大規模增資價格在 68 元，無實體股票也在今日(7/8)發放，賣壓極其輕微，等於是市場上持有仲恩的股東，在經歷電子狂潮加上市場大幅修正情境下，現階段基本不會賣出。對比近期的仁新，一樣是明年取證，此時此刻的仲恩可以說是就是 300 元的仁新，一旦市場發現其價值，其股價爆發力會極其驚人。